

ЛЕЙОМІОМА МАТКИ

Сценарій.

Ви лікар акушер - гінеколог. До вас на прийом звернулася жінка 35 років. Скарги на рясну менструацію зі згортками та загальну слабкість. З анамнезу – менструації з 13 років, протягом останнього року рясні та болючі. Шкіра та слизові бліді. Дихальна та серцево-судинна системи без патології. З перенесених захворювань - захворювань відмічає бронхіт, гастрит. Матка при бімануальному дослідженні збільшена до 14 тижнів вагітності, щільна. Придатки не визначаються. Виділення слизові. Тест сечі на ХГЛ — негативний. Визначити результат клінічного аналізу крові, сечі та ультразвукового дослідження. Встановити провідний синдром, попередній діагноз і визначити подальший шлях пацієнтки. Розробити заходи щодо профілактики здорового способу життя та врахувати легальні й етичні аспекти ведення пацієнтки.

Клінічний аналіз крові

Показник	Значення
Гемоглобін (г/л)	96
еритроцити ($10^{12}/л$)	3,1
Кольоровий показник	0,79
Тромбоцити ($10^9/л$)	235,5
ШЗЕ (мм/год)	10
Лейкоцити ($10^9/л$)	6,5
Лімфоцити %	20
Еозинофіли %	0
Паличкоядерні нейтрофіли %	6
Сегментоядерні нейтрофіли %	71
Моноцити %	3

Клінічний аналіз сечі

Показник	Значення
Кількість	100 мл
Колір	Світло-жовтий
Прозорість	прозора
Питома вага	1,012
Білок	немає
Цукор	немає
Мікроскопія сечового осаду	
Лейкоцити	5-6 у п/з
Еритроцити	1-2 екз у п/з
Циліндри гіалінові	немає
Солі	немає
Слиз	немає
Бактерії	немає

Ультразвукове дослідження

Субмукозний міоматозний вузол



Алгоритм виконання практичних навичок та вирішення клінічних кейсів

Алгоритм виконання		Форма представлення
1.Продемонструвати навички комунікації.		
1.1	Привітання з пацієнткою, встановлення контакту.	Сказати Доброго дня. Я лікар акушер-гінеколог. Мене звати...
1.2	Отримання інформаційної згоди на проведення клінічного дослідження	Сказати Ви даєте свою згоду на проведення клінічного дослідження (Будемо вважати що згода отримана)
1.3	Обробити руки на гігієнічному рівні та вдягнути захисну маску і рукавиці.	Сказати Будемо вважати, що руки оброблені
2. Збір скарг та анамнезу		
2.1	Скарги пацієнтки	Сказати: «Які у вас скарги?» Очікуваний відповідь: «Рясну менструацію зі згортками та загальну слабкість.»
2.2	Анамнез життя	Сказати: «Які захворювання ви перенесли?» Очікувана відповідь: «бронхіт, гастрит»
2.3	Менструальна функція	Сказати: «Чи були порушення менструального циклу» Очікувана відповідь: «останнього року рясні та болючі»
3.Об'єктивне обстеження		
3.1	Загальний стан.	Сказати: Стан задовільний, серцево-судинна та дихальна системи: без порушень.
3.2	Акушерське обстеження	Сказати: Матка при бімануальному дослідженні збільшена до 14 тижнів вагітності, щільна.
3.3	Піхвове дослідження	Сказати: Придатки не визначаються. Виділення слизові.

3.4	Уточнити у пацієнтки її самопочуття.	Сказати « Як Ви себе почуваєте? »
-----	--------------------------------------	-----------------------------------

		Очікувана відповідь: Добре
4. Діагностика		
4.1	Визначити результат клінічного аналізу крові	Сказати: знижені показники гемоглобіну, еритроцитів, кольорового показника- анемія
4.2	Визначити результат клінічного аналізу сечі	Сказати – норма . Тест сечі на ХГЛ — негативний .
4.3	Визначити результат ультразвукового дослідження	Сказати- Субмукозний міоматозний вузол
4.4	Визначити провідний синдром	Сказати- геморагічний, анемічний
4.5	Встановити клінічний діагноз	Сказати : Лейоміома матки. Анемія
13. Визначення тактики ведення та лікування		
5	Призначити подальшу тактику ведення	Сказати : госпіталізація у стаціонар для лікування Гормональна терапія (за показаннями). Призначення препаратів заліза при анемії. Динамічне спостереження за розмірами матки та станом ендометрія.
14. Профілактика та пропаганда здорового способу життя		
6	Рекомендувати профілактичні заходи	Сказати :- Спокійний режим, уникнення фізичних навантажень. - Раціональне харчування (білки, залізо, вітаміни).
7. Інше (в т.ч. легальні та етичні аспекти)		
7	Інформування пацієнтки про можливі ризики та етичні аспекти	Сказати- Ви повинні знати про можливі ризики, які можуть виникнути при вашому стані. <i>Можливе безпліддя (внаслідок порушення процесів імплантації, здавлення маткових труб.), при вагітності – підвищений ризик невиношування, передчасних пологів, відшарування плаценти</i> <i>Можливі:</i> <i>Некроз міоматозного вузла</i> <i>Інфікування міоми</i> <i>Малігнізація (утв. лейоміосаркома)</i>